

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE PADUA REVISADO — FORMA WSU (PI-WSUR)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Síntomas Obsesivo-Compulsivos Específicos (39 ítems)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Padua Revisado - Versión Washington State University (PI-WSUR).
Nombre Original (Inglés)	<i>Padua Inventory - Washington State University Revision (PI-WSUR)</i>
Autores Originales	G. Leonard Burns, D. A. Keortge, G. M. Formea y C. F. Sternberger (1996), sobre Sanavio (1988).
Adaptaciones Españolas	David Mataix-Cols, M. Sánchez-Turet y M. Vallejo-Sánchez (1999, 2002); Bobes et al. (2004).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación refinada de subtipos de TOC sin solapamiento con ansiedad.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 39 reactivos de 5 anclajes (0 = Nada a 4 = Muchísimo) organizados en 5 factores puros.
Población y Rango	Adultos y adolescentes (≥ 15 años). Consultas clínicas de salud mental, investigación y peritajes.
Tiempo de Administración	8 a 12 minutos.
Régimen de Licencia	Acceso para investigación y clínica conforme a directrices de los autores originales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y PURIFICACIÓN FACTORIAL DE BURNS

El PI-WSUR surgió como una respuesta metodológica indispensable ante un defecto psicométrico ampliamente documentado del Inventario de Padua original de 60 ítems (Sanavio, 1988): su factor de “pérdida de control mental” mostraba un solapamiento masivo con la preocupación generalizada de la ansiedad (TAG) y el ánimo depresivo, inflando artificialmente las puntuaciones en pacientes sin TOC.

Burns y colaboradores (1996) depuraron el instrumento eliminando 21 reactivos inespecíficos de indecisión y rumiación ansiosa común, reteniendo únicamente 39 ítems estrictamente obsesivo-compulsivos. La escala resultante aísla cinco dimensiones psicopatológicas puras: **contaminación/lavado**, **comprobaciones físicas**, **comprobaciones mentales**, **impulsos perjudiciales temidos** y **precisión/simetría**. En España, los trabajos pioneros de Mataix-Cols y cols. (1999, 2002) ratificaron que el PI-WSUR posee una especificidad diagnóstica muy superior frente a otros trastornos de ansiedad.

3. ESTRUCTURA FACTORIAL DE 5 FACTORES DEL PI-WSUR (BURNS ET AL., 1996)

Factor Puro PI-WSUR	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Semiológica
1. Contaminación y Lavado	10 reactivos	0 a 40	Miedo a microbios, suciedad, contagios corporales y rituales de lavado repetitivo de manos.
2. Comprobación Física	10 reactivos	0 a 40	Verificación compulsiva de puertas, llaves de paso, gas, luces, grifos y papeles oficiales.
3. Verificación Mental	7 reactivos	0 a 28	Repetición mental de frases, recuento silencioso de números y chequeo obsesivo de recuerdos.
4. Impulsos Temidos / Daño	7 reactivos	0 a 28	Miedo patológico a perder el control y proferir obscenidades, agredir o provocar daños graves.
5. Precisión y Simetría	5 reactivos	0 a 20	Necesidad obsesiva de alinear objetos, orden milimétrico y perfeccionismo motor rígido.
PUNTUACIÓN TOTAL PI-WSUR	1 al 39	0 a 156	Índice multidimensional puro de severidad sintomática de TOC.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad en la validación española de Mataix-Cols et al. (1999, 2002): alfa de Cronbach de 0.93 para la escala total. Las subescalas individuales muestran alfas entre 0.81 y 0.89.
Validez Discriminante Superior	A diferencia del Padua clásico de 60 ítems, el PI-WSUR no presenta correlaciones espurias elevadas con medidas de depresión mayor o preocupación inespecífica del TAG.
Sensibilidad y Especificidad	Para el punto de corte estándar <i>ge40</i> : sensibilidad diagnóstica del 88% y especificidad del 91% frente a criterios diagnósticos formales del DSM-IV y DSM-5.
Validez Concurrente	Correlación elevada con la Y-BOCS ($r = 0.72$) y con el inventario OCI-R ($r = 0.75$).
Estabilidad Temporal	Fiabilidad test-retest $r = 0.83$ a las 4 semanas en pacientes ambulatorios estables.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DE ÍTEMS

Cada uno de los 39 reactivos se califica en una escala Likert de 5 puntos:

- **0** = Nada / Para nada | **1** = Un poco | **2** = Bastante | **3** = Mucho | **4** = Muchísimo.
- **Puntuaciones de Subescalas:** Suma directa de los reactivos de cada uno de los 5 factores:

Contaminación (0-40) | Comprobación (0-40) | Mental (0-28) | Impulsos (0-28) | Precisión (0-20)

- **Puntuación Total PI-WSUR:** Suma directa de los 39 reactivos (Rango: **0 a 156 puntos**).

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (MATAIX-COLS ET AL., 1999; BURNS, 1996)

Estrato	Puntuación	Estado Clínico	Conducta Asistencial Recomendada
No Clínico	0 a 24	Población no clínica habitual	Ausencia de síntomas obsesivos perturbadores. Autocuidado y vida saludable.
Subclínico	25 a 39	Rasgos obsesivos moderados	Preocupaciones intrusivas periódicas. Psicoeducación en flexibilidad cognitiva.
Clínico	40 a 64	Corte Positivo para TOC (≥ 40)	Sintomatología clínicamente significativa. Terapia de elección mediante técnica de EPR.
Severo	65 a 156	TOC Grave / Incapacitante	Afectación multiarea severa y colapso funcional. Tratamiento combinado intensivo (EPR + ISRS).

VENTAJA DEL FACTOR “VERIFICACIÓN MENTAL”: La inclusión explícita del Factor 3 (Comprobaciones Mentales y Recuento) en el PI-WSUR permite capturar los rituales encubiertos en los pacientes catalogados erróneamente como “obsesivos puros sin compulsiones”, facilitando la prevención de respuesta cognitiva.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y JERARQUÍA TERAPÉUTICA

DISEÑO TERAPÉUTICO BASADO EN SUBTIPOS DEL PI-WSUR:

- **Subtipo Contaminación / Lavado:** Exposición en vivo a fómites sin permitir lavados de manos ni uso de alcohol hidroalcohólico.
- **Subtipo Comprobación Física:** Exposición guiada a situaciones de riesgo percibido suprimiendo verificaciones visuales o mecánicas repetidas.
- **Subtipo Verificación Mental:** Exposición imaginal a la duda obsesiva prohibiendo la repetición silenciosa de números, listas o contra-pensamientos mágicos neutralizadores.
- **Subtipo Precisión y Simetría:** Exposición deliberada a desorden asimétrico entrenando la tolerancia a la incomodidad somatosensorial.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN RITUALES MENTALES

Paciente: Mujer de 26 años, graduada en Farmacia, que consulta por severa dificultad para estudiar oposiciones debido a la necesidad continua de releer cada párrafo hasta 10 veces y repetir secuencias numéricas en su mente para evitar que “le suceda una desgracia a su familia”.

Resultados PI-WSUR:

- **Puntuación Total:** 68/156 (**Rango Severo — Corte Positivo**).
- **Desglose factorial:** Factor 3 (Verificación Mental) = 24/28 (máxima elevación en rituales de recuento y chequeo de memoria); Factor 2 (Comprobación) = 18/40; Factor 1 = 6/40; Factor 4 = 8/28; Factor 5 = 12/20.

Conducta Asistencial: Se diagnostica Trastorno Obsesivo-Compulsivo con predominio de rituales mentales neutralizadores (DSM-5). Se implementa protocolo de EPR para compulsiones encubiertas: lectura continua sin pausas ni relecturas, bloqueando el recuento mental mediante la verbalización en voz alta de un poema o canción neutra durante la tarea. A las 10 semanas de intervención, el Factor 3 se redujo a 6/28 y la puntuación global descendió a 22/156 (rango normal), logrando reanudar con éxito su plan de estudio.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: INTROMISIÓN EN CONVIVENCIA

En el subtipo de Comprobación y Simetría, los pacientes suelen obligar a sus familiares a participar en rituales bajo amenazas de ira; trabajar pautas de desacomodación familiar.

EVALUACIÓN DE IDEACIÓN SUICIDA

El agotamiento mental crónico producido por verificaciones cognitivas ininterumpidas genera episodios de depresión reactiva severa con ideación de muerte; explorar con PHQ-9.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Burns, G. L., Keortge, D. A., Formea, G. M., & Sternberger, C. F. (1996). Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsive disorder symptoms: Concurrent and discriminative validity. *Behaviour Research and Therapy*, 34(2), 163–173.
2. Mataix-Cols, D., Sánchez-Turet, M., & Vallejo-Sánchez, M. (1999). Factor structure of the Padua Inventory-Washington State University Revision in a Spanish clinical sample. *European Journal of Psychological Assessment*, 15(3), 198–205.
3. Mataix-Cols, D., Rauch, S. L., Manzo, P. A., Jenike, M. A., & Baer, L. (1999). Use of factor-analyzed symptom dimensions to predict outcome with serotonin-reuptake inhibitors and behavior therapy in obsessive-compulsive disorder. *American Journal of Psychiatry*, 156(9), 1409–1416.
4. Sanavio, E. (1988). Obsessions and compulsions: the Padua Inventory. *Behaviour Research and Therapy*, 26(2), 169–177.